2026.8.15–8.16 · 马来西亚场

神经重置

从感觉、疼痛到日常功能

用感觉与动作的联系读懂两天课程，将局部演示、连续个案和长期功能放在同一张地图中。

阅读方式

先看地图，再读主题；用表格比较，用逻辑图串联。正文编号可跳转到出处索引；无需在大段原文中反复寻找。

本课目录

01 整门课的地图：从感觉走向生活

02 概念对照：感觉、疼痛与身体认识

03 统一的观察语言：先把问题说清楚

04 区域地图：把零散部位放回整体

05 连续个案：把变化和未解决项放在一起

06 从当场变化到动作学习与日常训练

07 理解课程模型，也看清它的解释范围

08 一张复盘表：把知识用在清楚的记录上

资料范围：45份。各篇主题映射与具体文件页码见书末出处索引。

本书用于课程学习与复盘。课堂模型、现场观察、整理补充和外部核对分别表达；原文与旧版逐篇PDF保留在原资料夹。

整门课的地图：从感觉走向生活

课程反复围绕一个问题展开：身体提供的信息、本人感受到的状态，以及实际做出的动作，如何联系起来？讲者用“整合”“不匹配”“脱敏”组织解释，并通过接触、视觉反馈和动作演示观察变化。全局阅读时，可把理论、区域索引、个案和日常训练串成四层。[8.15-01][8.15-02][8.15-03][8.15-11]

理解层

辨认中枢与周围、感觉输入与动作表现。先知道每个词在说什么，再讨论它能解释哪些现象。

观察层

把“痛、麻、没力、卡住”拆开；每次比较固定一个问题和任务，让前后结果有可比性。

生活层

课堂动作变好后，还要回到站立、走路、抓握等原先受影响的任务，并追踪是否保持。

阅读层次	要回答的问题	课程中的连接
概念基础	身体怎样接收、理解和回应信息？	中枢/周围、身体意象、疼痛调节。[8.15-02][8.15-05]
局部区域	课程在哪些区域观察和示范？	颈肩、上肢、腰髋、膝踝与足部；区域名称只是回看索引。
个案比较	哪一项变化了，哪一项仍未变化？	同一个案可能跨多份文件；需串联基线、各阶段和残余问题。
功能迁移	回到生活后是否更容易完成任务？	ADL指日常生活活动，站坐差异、负重差异都应保留。[8.15-11]
维持与复盘	当场变化是否延续，发生了哪些新情况？	次日反馈、复发、训练负荷与生活影响。[8.15-12][8.16-01]

描述问题 → **建立基线** → **观察变化** → **回归生活**

具体困扰与生活影响 | 同一个人、同一任务 | 感觉与功能分别看 | 持续性与真实需求

把这些内容连起来

整理补充：这四步是一种阅读和记录方法，不是宣称任何症状都能用同一技术处理。“局部舒服”与“生活功能恢复”之间还有一步：重新完成原来困难的任务。例如坐着足部动作减痛以后，站立和走路是否仍痛，需要另测。[8.16-20][8.16-21]

复习与应用

复习时先用一句话说出当事人最想改善的生活任务，再解释相关概念。这样可以避免只记点位、产品或即时分数。

概念对照：感觉、疼痛与身体认识

“感觉变清楚”“痛减轻”“更能用力”分别属于体验、症状和功能层面。它们可能同时变化，也可能只改变一项。把这几层分开，才能理解课堂演示，而不从单一反馈直接跳到病因结论。[8.15-02][8.15-03][8.15-05][8.15-06]

中枢与周围

中枢包括脑和脊髓，周围神经连接身体各处。课程的CPU比喻帮助入门，实际关系包含来回传递与调节。

身体意象

闭眼时对身体形状、大小或清晰度的描述，属于主观体验。它不等同于正式的感觉检查。

疼痛调节

感觉输入可能改变疼痛体验。疼痛本身是真实的个人体验，需要尊重，不能用“大脑参与”否认它。[E01]

概念	抓住什么	容易混淆的地方
触觉	皮肤接触等信息	触到哪里，不等于已确定哪里是病因。
本体感觉	身体位置与运动相关信息	不等同肌力大小，也不等同闭眼想象是否清晰。
伤害性感受	对可能伤害组织的刺激进行编码	与疼痛体验相关，但不能直接画等号。[E01]
A类、Aδ与C纤维	不同纤维类型和功能的讨论	不能整体分成“好神经”和应消除的“坏神经”。[8.15-05]
闸门理论	课程用来理解感觉输入与疼痛调节	“C纤维挡住身体认识”是讲者延伸模型，不能作为所有症状的通用机制。[8.15-05]
不匹配/脱敏	讲者用来组织问题与处理的词	即时改变不证明已直接测到或修复了某条神经。[8.15-03][8.15-10]

输入 → **体验** → **动作** → **反馈**

接触、视觉、位置等信息 → 痛感、身体形象、舒适度 → 范围、力量、任务完成 → 重新记录并比较

把这些内容连起来

整理补充：可以同时问“感觉如何”和“能做什么”。例如手指张开更大而仍有手抖，是两项不同结果，不矛盾，也不能把它合写成“手恢复正常”。课堂解释可作为假设，但要证明特定机制，还需要相应测量和对照。[8.15-19][8.15-20]

复习与应用

尝试分别解释：疼痛、伤害性感受、触觉、本体感觉、身体意象。能否各给一个课堂例子，而不把它们混成“感觉神经”？

统一的观察语言：先把问题说清楚

“腰痛”“手麻”“脑雾”“五十肩”都可能把多种体验压在一个标签里。课程中的有效问诊片段，会回到部位、时间、诱发任务和本人描述；实际记录还应把既往诊断、检查结果和讲者推测分栏保存。[8.15-07][8.16-02][8.16-04][8.16-20]

本人描述

让本人说完、指出部位、解释“麻”“卡”“没力”具体指什么。不要由旁观者代答。

可比条件

固定姿势、支撑、动作、负重和提问方式。条件不同的分数分别记录。

结果全貌

改善、无变化、残余症状和新增不适都进入记录；未测到的项目明确留空。

记录项	具体写法	为什么需要
主要目标	“走路时足背痛”，而非笼统“脚不好”	让后续比较对准最影响生活的问题。[8.16-20]
发生模式	何时开始、持续多久、坐站和活动有何差别	区分同部位不同场景的困扰。[8.15-11][8.16-05]
感觉类型	疼痛、感觉减少、针刺/虫爬、抖动分别写	一个“麻”字不能代表完整症状。[8.15-19]
功能任务	抓握、张指、弯腰、跪坐、负重行走	“舒服了”与“能完成”是两种结果。[8.16-18][8.16-19]
既往资料	本人自述与实际报告分列；记录用药和手术背景	不凭课堂观察重判影像，也不抹掉病史。[8.15-15]
复测时点	当场、稍后、次日和之后的生活表现	当场评分不等于维持时间。[8.15-11][8.15-12]

听取主诉 → **选定任务** → **分步复测** → **延后核查**

用当事人的语言 | 标清条件与基线 | 逐项记录所有结果 | 看生活表现与持续性

把这些内容连起来

整理补充：分数必须带着问题一起保存。“3分”如果分别来自坐姿、站立和他人按压，就不是同一把尺子。类似地，正常肌力是一个检查结果，不能替代其他检查；单侧头痛也不自动等同于偏头痛。[8.16-04][8.16-13][8.16-21]

复习与应用

一份清楚的结论可以写成：“在相同站姿任务下，当事人自评痛感减轻，走路仍不适；持续时间待追踪。”不要删掉后半句。

区域地图：把零散部位放回整体

两天课程从颈肩和上肢，逐步转到腰髋、盆底、下肢及平衡。下面是课程术语与文件的导航图，帮助定位内容；它不是完整神经支配图，也不把某处症状直接等同于某条神经疾病。

先认区域

让本人指出部位，区分肩上方、肩关节、后肩及手部等区域。

再认术语

辨认课程提及的神经名称，明显错字可校正；节段冲突和“这里”保留待核。

最后看任务

回到抬臂、抓握、站立和跪坐等活动，观察区域之间怎样共同参与。

课程区域	关键词与主要内容	关联到的观察任务
颈部/耳周/枕后	颈横、耳大、枕小及锁骨上神经；声音、咳嗽与面部案例。[8.15-08][8.15-09][8.15-10]	转头、抬臂、声音及面部动作；即时反应不能确定病因。
肩与上肢	肩手疼痛、外侧/内侧分组，桡神经沟、胸小肌等课堂位置。[8.15-13][8.15-14][8.15-18][8.15-20]	拇指活动、张指、握持与手工对抗；施力条件需一致。
腰背与髋周	臀上皮、臀中皮、股外侧皮、髂腹相关及生殖股神经话题。[8.16-06][8.16-09][8.16-12][8.16-13]	坐站、前后弯腰、压痛及异物感；主观与结构分开。
胸背与瘢痕	脊旁节段、胸部不适、术后压痛。[8.16-14][8.16-15][8.16-16][8.16-17]	自发痛与触压痛分列；局部减痛不代表内脏或术后结构恢复。
膝、踝与足	隐神经、股外侧皮、腓总和股后皮等课堂回顾。[8.16-18][8.16-21]	跪坐需膝踝髋腰配合；坐姿与负重结果不能合并。
枕下与平衡	颈部本体感觉、视觉和前庭的课程联系。[8.16-22][8.16-23]	站立策略、踝部活动与转头诱发症状；多系统共同参与。[E04]

症状区域 哪里、怎样不舒服 → **相关概念** 课程使用哪些词 → **功能任务** 哪些部位共同参与 → **复测结果** 哪一项真正改变

把这些内容连起来

整理补充：一张区域表的价值在于找到相关段落，而不是把所有表现装进固定“点位→疾病”的配对。课程将上游与下游比作父子或河流，这有助记忆，但解剖、临床诊断和疗效判断仍是不同层次。

复习与应用

选择一个生活任务，说明至少两个可能参与的部位。例如跪坐不仅包含膝屈曲，也涉及踝跖屈、髋腰配合及支撑条件。

连续个案：把变化和未解决项放在一起

这些案例分散在多份文件中，整合后更容易看见它们共同的学习价值：明确基线、分阶段观察、保留残余问题。下表按主题串联，均为课堂记录或讲者回顾，不代表已验证的治疗效果。

比较单位

同一个人、同一种症状、同一个任务。不能把多人反馈拼成一条成功路径。

干预数量

接触、产品、动作、支撑和提示往往同时变化，单一方法的贡献未被分离。

结局范围

课堂结束时未解决的项目继续保留；没有随访就不补写长期结果。

案例线索	课堂中的主要变化	对全局理解的帮助
肩手痛与残余手痛	前段部分动作8–9分，后述约3分或1–2分；后续另一动作仍约5分。[8.15-13][8.15-14][8.15-19]	不同任务的分数不能拼成一条精确疗效曲线。
手麻、手抖跨日复查	张指较前增加但仍抖；次晨再次反馈麻、抖及动作限制。[8.15-19][8.15-20][8.16-01]	“复发”需拆成哪些改善保留、哪些再次出现。
多部位拉扯与耳鸣	颈部约6→2分，左右腿变化不同；整体活动更容易，但缺完整终点评分。[8.15-15][8.15-16]	分左右、分部位记录，不能以整体舒服覆盖残余。
长期腰痛	先建病史和坐站基线，颈部与腰臀分段处理后报告减轻；坐姿更自然。[8.16-05][8.16-06][8.16-07]	影像标签、当前痛感、任务表现应分别解释。
膝痛与跪坐	走动舒服以后跪坐仍困难，增加腰臀观察、支持及模仿后可下得更低。[8.16-18][8.16-19]	减痛、活动度和动作学习不是同一个结果。
足背痛	颈部触碰曾无变化；局部处理后部分改善，负重仍有残余痛。[8.16-20][8.16-21]	阴性结果有价值；坐姿改善还须回到走路。
面部抽动	头位变化与抽动有关；后续报告闭眼减少，仍有少量抽动。[8.15-08][8.16-22][8.16-23]	触发关联与症状改变均不足以确诊或排除其他病因。

基线 → **过程** → **结果** → **后续**

症状与任务 | 每次改变的条件 | 改善和残余并列 | 生活功能与随访

把这些内容连起来

阅读案例时，可先找“没有变化”和“仍然存在”的句子。它们让结果的范围更清楚，也帮助确定下一次真正需要观察的问题。术后瘢痕、盆底下坠或异物感等案例，同样遵守这一逻辑：感受改变不能代替组织检查。[8.16-10][8.16-11][8.16-13][8.16-17]

复习与应用

任选一例，用三句话复述：原来哪项任务困难；现场发生了什么变化；结束时仍不知道什么。

从当场变化到动作学习与日常训练

课程最终希望把感觉变化带回实际动作。补齐的11号文件明确谈到ADL；次日的跪坐、负重足痛和平衡案例则说明：同一人在不同任务条件下，表现可以不同。训练的目标应写成可观察的生活能力。[8.15-11][8.15-21][8.16-19][8.16-21]

感觉目标

痛、紧、麻或陌生感如何变化；描述本人的体验。

任务目标

走、站、握、坐等活动能否更自然完成；说明支撑与负重。

维持目标

活动之后和次日如何，生活是否更方便；将短时变化与长期保持区分。

环节	课程中可借鉴的原则	扩充理解
选择任务	回到原先不舒服的生活情境。[8.15-11]	复测应在可耐受范围内进行，不等于反复制造疼痛来证明有效。
降低难度	从有支持或较容易的动作开始，再看能否完成。[8.16-19]	记录支持条件，才能知道是任务变简单，还是能力改变。
反馈学习	视觉、模仿及重复尝试可被纳入观察。[8.15-03][8.16-19]	一次表现包含熟悉任务、注意与提示等因素，不能只归因手法。
心肺与力量	课程反复提倡结合两类活动。[8.15-21][8.16-24]	一般成人可参考每周150–300分钟中等强度，或75–150分钟高强度有氧，并安排肌力活动。[E02]
强度与恢复	写清活动类型、强度、时长、频率及练后反应。	4×4属于特定高强度框架；相关资料采用85%–95%最大心率，不能照搬课堂100%目标。[8.16-24][E09]
个体差异	保留疲劳、头晕、术后限制及活动后恶化的反馈。[8.16-02][8.16-23]	训练安排随健康背景和耐受调整，不按年龄、性别或器械名称一概判断。

选生活目标 → **确认可完成范围** → **观察训练反应** → **再调整安排**

一个具体任务 → 支持、幅度与负荷 → 症状、功能与恢复 → 依据实际反馈

把这些内容连起来

整理补充：功能迁移可用三层理解——课堂能完成、不同条件能完成、日常持续能完成。这是对案例的归纳，不是额外制定的康复处方。水中活动、力量训练和间歇训练提供不同任务条件，讲者个人偏好不能取代个体选择。[8.16-24]

复习与应用

把“加强运动”改写为一份可讨论的记录：活动目标、现有能力、采用的任务、观察哪些反应，以及何时复盘。不要只写一个运动名称。

理解课程模型，也看清它的解释范围

“变化很快”说明变化发生在短时间内；它本身不能证明唯一病因、确定神经定位或预测维持多久。课程中的生理概念、机制假设、个案回顾、产品主张和商业经验，需要放在不同层级阅读。[8.15-04][8.15-10][8.15-11][8.16-03]

概念与模型

先确认定义，再看讲者如何使用。模型能帮助提问，不自动成为每个个案的结论。

观察与机制

“处理后感觉轻松”是观察；“关闭了某种纤维”是机制解释，二者需要不同证据。

经验与推广

个体回忆不能给出普遍有效率。产品说明、资历和客户复购也不能代替比较研究。

课堂延伸话题	全局笔记中的定位	进一步理解
膏剂与激光	保留为讲者的产品/技术主张。[8.15-10][8.15-11][8.16-03]	现有材料未提供足够成分、参数、对照及不良反应资料，不能组成治疗方案。
面食、奶与小脑	属于未证实的通用因果推断。[8.15-16][8.15-17]	乳糜泻等具体疾病有诊断路径；不能推广到所有人，先去除麸质可能影响检查。[E08]
年龄、性格与疗效	属于讲者解释，缺少比较资料。[8.15-11]	疗效差异不能用来判断一个人固执、脑退化或不配合。
“摸后好转”排除病变	不能成立为诊断排除规则。[8.15-08][8.16-14]	症状缓解与是否需要进一步检查，是两个问题。
盆底、痔疮、术后问题	课堂有下坠感和压痛改变。[8.16-09][8.16-10][8.16-17]	感觉收紧不等于组织复位；局部减痛不代表手术没有必要。
皮肤反应与接触边界	操作后反应和个人触碰意愿应分别记录。[8.16-08]	未见即时反应不能排除后续问题；不愿被触碰不等于人格或神经异常。

识别主张 → **找对应证据** → **检查跨度** → **保留结论边界**

它具体断言什么 | 观察、检查还是研究 | 是否超出证据范围 | 未知明确写未知

把这些内容连起来

整理补充：这不是给课程所有内容贴统一标签，而是让每条信息各得其所。区域名词用于定位阅读，案例用于学习观察，权威资料用于校正基础概念。尚未核实的论文、百分比和口述术语，不以流畅表达补成确定事实。

复习与应用

遇到“百分之百”“所有问题”“一次解决”时，追问其对象、测量指标、比较条件和随访时间。四项缺失时，不把它写进客户的效果承诺。

一张复盘表：把知识用在清楚的记录上

以下是根据两天课程归纳的学习记录模板。它用于课程复习和沟通，不是诊断量表。一次只聚焦一个主要问题，将实际观察与解释分开，最后回到本人最在意的生活影响。[8.15-07][8.15-11][8.16-07][8.16-20]

学习前

选一个主题，写出已有理解与最想回答的问题。无需一次记住全部神经和区域。

阅读时

先看概念，再追踪一个连续个案；遇到跨文件的片段，用出处编号接回前后。

复盘后

用自己的话解释主线，标出能确认的结果、尚缺的信息和需要继续查证的问题。

记录栏	可以填写的内容	检查问题
主要困扰	部位、开始时间、本人描述、生活影响	我是在记录本人体验，还是提前替他下结论？
目标任务	具体动作、姿势、负重与支撑条件	后面能否在相同条件下再观察？
基线	症状评分、动作表现、已有检查分别记	每个分数对应哪个症状和任务？
过程	依次发生了哪些变化、由谁实施	是否有多个环节同时改变？
即时结果	改善、未变化、残余与新增不适	有没有只挑好看的结果？
后续记录	当日/次日/生活场景的反馈，未得知则留空	是否把预测写成已经发生？
解释与来源	课程解释、自己的问题、文件编号	结论是否超过现有资料？

回忆概念 → **读懂个案** → **填写记录** → **核查出处**

用自己的话解释 | 按时间线串联 | 固定任务和指标 | 回到具体文件

把这些内容连起来

跨课题连接：本课的“感觉—动作—生活功能”框架，在女性脑科学里会扩展到睡眠、压力、消化、排尿和性健康。共同的是记录方法；不同主题仍有各自的专业知识与评估路径，不能因为共用感觉语言就合并成同一种疾病。

复习与应用

完成自测：①区分体验与结构；②解释一次减痛为何不等于治愈；③举例说明不同任务不能混评分；④说明ADL的意义；⑤指出一个未核实的课堂主张及其缺少的证据。

课程出处索引

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.15-01] 课程导入与问题意识

独立PDF：01_课程导入与问题意识_笔记与原文.pdf

8.15/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第4页

[8.15-02] 中枢、周围与身体意象

独立PDF：02_中枢、周围与身体意象_笔记与原文.pdf

8.15/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第8页

[8.15-03] 感觉反馈与视觉演示

独立PDF：03_感觉反馈与视觉演示_笔记与原文.pdf

8.15/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第12页

[8.15-04] 疼痛解释与证据意识

独立PDF：04_疼痛解释与证据意识_笔记与原文.pdf

8.15/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第16页

[8.15-05] 感觉纤维与闸门理论

独立PDF：05_感觉纤维与闸门理论_笔记与原文.pdf

8.15/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第20页

[8.15-06] 伤害性感受与敏化

独立PDF：06_伤害性感受与敏化_笔记与原文.pdf

8.15/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第24页

[8.15-07] 主观症状与功能评估

独立PDF：07_主观症状与功能评估_笔记与原文.pdf

8.15/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第28页

[8.15-08] 颈部感觉分支与面部案例

独立PDF：08_颈部感觉分支与面部案例_笔记与原文.pdf

8.15/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第31页

[8.15-09] 颈部触觉与腰痛咳嗽案例

独立PDF：09_颈部触觉与腰痛咳嗽案例_笔记与原文.pdf

8.15/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第35页

[8.15-10] 颈部练习与产品说明

独立PDF：10_颈部练习与产品说明_笔记与原文.pdf

8.15/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第39页

[8.15-11] 效果维持与生活功能

独立PDF：11_效果维持与生活功能_笔记与原文.pdf

8.15/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第43页

[8.15-12] 效果维持与社区分享

独立PDF：12_效果维持与社区分享_笔记与原文.pdf

8.15/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第46页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.15-13] 锁骨上神经与肩手疼痛

独立PDF：13_锁骨上神经与肩手疼痛_笔记与原文.pdf

8.15/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第51页

[8.15-14] 肩手案例复测与肩部无力

独立PDF：14_肩手案例复测与肩部无力_笔记与原文.pdf

8.15/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第55页

[8.15-15] 多部位不适个案与基线

独立PDF：15_多部位不适个案与基线_笔记与原文.pdf

8.15/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第59页

[8.15-16] 多部位个案的阶段反馈

独立PDF：16_多部位个案的阶段反馈_笔记与原文.pdf

8.15/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第63页

[8.15-17] 饮食观点与证据边界

独立PDF：17_饮食观点与证据边界_笔记与原文.pdf

8.15/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第67页

[8.15-18] 上肢外侧主题与示范

独立PDF：18_上肢外侧主题与示范_笔记与原文.pdf

8.15/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第71页

[8.15-19] 残余手痛与麻木手抖

独立PDF：19_残余手痛与麻木手抖_笔记与原文.pdf

8.15/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第75页

[8.15-20] 上肢内侧主题与复测

独立PDF：20_上肢内侧主题与复测_笔记与原文.pdf

8.15/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第79页

[8.15-21] 训练复盘与课程收束

独立PDF：21_训练复盘与课程收束_笔记与原文.pdf

8.15/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第83页

[8.16-01] 手部症状的复测与身体感知

独立PDF：01_手部症状的复测与身体感知_笔记与原文.pdf

8.16/1.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第3页

[8.16-02] 晨间状态、脑雾与运动讨论

独立PDF：02_晨间状态、脑雾与运动讨论_笔记与原文.pdf

8.16/2.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第7页

[8.16-03] 神经系统视角与课程适用范围

独立PDF：03_神经系统视角与课程适用范围_笔记与原文.pdf

8.16/3.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第11页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.16-04] 头痛术语与腰痛范围

独立PDF：04_头痛术语与腰痛范围_笔记与原文.pdf

8.16/4.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第15页

[8.16-05] 长期腰痛案例：先听病史

独立PDF：05_长期腰痛案例：先听病史_笔记与原文.pdf

8.16/5.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第19页

[8.16-06] 腰痛案例：分阶段观察变化

独立PDF：06_腰痛案例：分阶段观察变化_笔记与原文.pdf

8.16/6.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第23页

[8.16-07] 案例收尾与沟通边界

独立PDF：07_案例收尾与沟通边界_笔记与原文.pdf

8.16/7.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第27页

[8.16-08] 皮肤反应与接触不适案例

独立PDF：08_皮肤反应与接触不适案例_笔记与原文.pdf

8.16/8.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第30页

[8.16-09] 从敏感案例转入盆底讨论

独立PDF：09_从敏感案例转入盆底讨论_笔记与原文.pdf

8.16/9.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第34页

[8.16-10] 盆底与痔疮感的课堂示范

独立PDF：10_盆底与痔疮感的课堂示范_笔记与原文.pdf

8.16/10.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第38页

[8.16-11] 盆底讨论收尾：体验不等于诊断

独立PDF：11_盆底讨论收尾：体验不等于诊断_笔记与原文.pdf

8.16/11.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第42页

[8.16-12] 髋周不适与感觉区域梳理

独立PDF：12_髋周不适与感觉区域梳理_笔记与原文.pdf

8.16/12.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第44页

[8.16-13] 髋周与耻骨区域案例复测

独立PDF：13_髋周与耻骨区域案例复测_笔记与原文.pdf

8.16/13.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第48页

[8.16-14] 胸部不适与脊旁示范

独立PDF：14_胸部不适与脊旁示范_笔记与原文.pdf

8.16/14.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第52页

[8.16-15] 脊旁示范的简短补充

独立PDF：15_脊旁示范的简短补充_笔记与原文.pdf

8.16/15.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第56页

课程出处索引（续）

编号对应日期与文件；独立PDF第1页为原有笔记。合订本页码指PDF物理页序，原文仍保留在原资料夹。

[8.16-16] 脊旁节段、平衡与瘢痕问答

独立PDF：16_脊旁节段、平衡与瘢痕问答_笔记与原文.pdf

8.16/16.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第58页

[8.16-17] 乳腺术后瘢痕痛案例

独立PDF：17_乳腺术后瘢痕痛案例_笔记与原文.pdf

8.16/17.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第62页

[8.16-18] 膝痛与跪坐：建立功能基线

独立PDF：18_膝痛与跪坐：建立功能基线_笔记与原文.pdf

8.16/18.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第66页

[8.16-19] 膝痛复测与动作再学习

独立PDF：19_膝痛复测与动作再学习_笔记与原文.pdf

8.16/19.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第70页

[8.16-20] 青年足背痛：会诊式问诊

独立PDF：20_青年足背痛：会诊式问诊_笔记与原文.pdf

8.16/20.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第74页

[8.16-21] 足背痛案例：负重与非负重复测

独立PDF：21_足背痛案例：负重与非负重复测_笔记与原文.pdf

8.16/21.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第78页

[8.16-22] 平衡观察与枕下示范

独立PDF：22_平衡观察与枕下示范_笔记与原文.pdf

8.16/22.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第82页

[8.16-23] 面肌痉挛复测与课末问答

独立PDF：23_面肌痉挛复测与课末问答_笔记与原文.pdf

8.16/23.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第86页

[8.16-24] 运动问答与课程结束

独立PDF：24_运动问答与课程结束_笔记与原文.pdf

8.16/24.doc | 笔记第1页 | 当日合订本第90页

外部核对与阅读说明

[E01] IASP｜疼痛定义与术语

疼痛是个人体验，不能仅从组织或神经信号推断。

https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/

[E02] WHO｜身体活动与久坐指南

一般成人有氧及肌力活动建议；不等于个体运动处方。

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789240014886

[E04] NIDCD｜平衡障碍

平衡涉及多个系统，评估和康复应个体化。

https://www.nidcd.nih.gov/health/balance-disorders

[E08] NIDDK｜乳糜泻诊断

诊断结合病史与检查；先自行去除麸质可能影响结果。

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/celiac-disease/diagnosis

[E09] NTNU CERG｜运动建议与4×4间歇

相关4×4框架采用85%至95%最大心率，不要求达到100%。

https://www.ntnu.edu/cerg/advice

整理口径

课程模型用于准确呈现讲者的思路；课堂观察只说明现场发生的变化；整理补充用于解释联系与阅读方法；外部核对以E编号标注。图中的箭头表示概念关系或复盘顺序，不自动代表已经证实的生理因果。依赖现场图像的手法不从残缺转写补成操作教程。

引用说明：以客户提供的课程标题与日期归档。课堂来源指向已生成的结构化笔记；外部核对仅用于对应基础知识与关键边界，不表示相关机构认可课堂技术。没有可统一核验的录音时间戳，因此不编造分钟定位。

版本：2026-10-30。8.15的11号文件已补齐；全部118份材料均完成通读与主题映射。原始资料未改动，公开版不附原文、个人身份或私人经历细节。